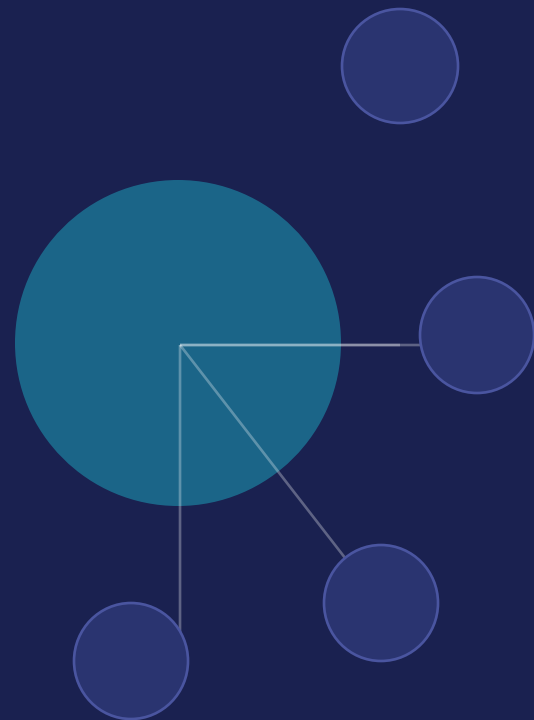


整体師向けセミナー

# 症状の分解

肩こり・腰痛は、なぜ痛む？

痛みのメカニズムを“分解”して、患者に語れる整体師になる



## QUESTION

患者さんに「なんで痛いんですか？」  
と聞かれて、説明できる？



「とりあえずほぐしときますね」

…で終わると、患者は“また来る理由”を持ってない。

「なぜ痛むのか」を分解して言葉にできる施術者は、信頼も再来率も変わる。  
今日は肩こり・腰痛の“なぜ”を、メカニズムまで分解していく。

TODAY

# 今日分解する 3 つの“なぜ”

01



## 肩こりは脳の錯覚？

“こり感”はどこから来るのか

02



## 腰痛が耐え難くなる理由

なぜあそこまで痛むのか

03



## ぎっくり腰のメカニズム

あの瞬間、何が起きている

## BASICS

# そもそも「痛み」とは何か

痛みは“組織が壊れた量”の計測値ではない。

体の信号を受けて、脳が「これは危険」と判断して出す最終アウトプット。



# 痛みの強さ $\neq$ 組織の壊れ具合



## 画像はキレイなのに激痛

ヘルニアや変形があっても無症状の人は多い。



## 同じ刺激でも痛みは変わる

不安・疲労・睡眠不足で痛みは増幅する。



## “痛い＝壊れてる”ではない

痛みは脳の警報。損傷の量とは別ものの。

CHAPTER 01

## 第1章

# 肩こりは 脳の錯覚？

“こり感”はどこから来るのか。筋肉と脳、両方の視点で分解する。

1



## まず“こり”の正体（体の側）



ここまでは“体”で実際に起きている悪循環。でも——話はこれで終わらへん。

# でも“こり感”は筋の硬さと一致しない



## ガチガチでも無症状

筋肉はカチカチに張っているのに、本人は「別につらくない」というケースは普通にある。



## 柔らかいのにつらい

逆に、触ると柔らかいのに強烈な“こり感”を訴える人もいます。硬さ＝つらさではない。

→ “こり”という感覚は、最終的に**脳が作っている**。



# なぜ脳が「こってる」と感じさせる？



## 感作（過敏化）

同じ部位への持続刺激で、神経が小さな信号も拾いやすくなる。



## 注意・意識

「ここがこってる」と意識を向けるほど感覚は強まる。



## ストレス・不安

心理的緊張が痛み・不快感のスイッチを増幅させる。



## 自律神経の乱れ

交感神経が優位だと血流低下と緊張が続きやすい。

# 「錯覚」＝“気のせい”ではない



やってはいけない説明

「気のせいですよ」  
「痛いと思い込んでるだけ」

患者は突き放されたと感じ、不信になる。



正しい理解

筋・血流の問題も、脳の増幅も、  
どちらも“本物”。

体と脳の合作。だから両方にアプローチできる。

※「錯覚」は“感覚が実態とズレる”という意味。痛みやこりは確かに存在している。

# 発痛物質（痛み物質）の放出

## プロスタグランジン

一番有名な発痛物質。  
筋肉や組織がダメージを受けると  
細胞膜から放出された脂肪酸（アラキドン酸）から作られる

## ブラジキニン

発痛物質界のラスボス。  
痛みを直接発生させる能力が強い。

## ヒスタミン

アレルギーで有名。花粉症の原因物質。  
血管を拡張させ、さらに神経も刺激する

## サイトカイン

免疫細胞同士のLINEみたいなもの。  
細胞同士の連絡ツール。

# だから、肩こり是这样攻める



## ① 局所をゆるめ血流改善

縮んだ筋を解いて循環を取り戻し、  
悪循環を断つ。



## ② 自律神経を整える

呼吸・リラックスで交感神経の過緊  
張をゆるめる。



## ③ “安心”を言葉で渡す

なぜこるか説明し、脳の警戒（感作）  
をやわらげる。

CHAPTER 02

## 第2章

# 腰痛が耐え難い 痛みになる理由

なぜあそこまで痛むのか。痛みを“増幅させる仕組み”を分解する。



## 痛みの“ボリューム”が上がる（感作）

痛みが続くと、脊髄や脳の痛みシステムそのものが過敏になる。小さな刺激でも強い痛みとして増幅されてしまう。

入力（刺激）

小



感作

出力（痛み）

大

## 体が“守ろうとして”固める（スパズム）

痛い部位を守ろうと、周りの筋が反射的にガチッと固まる。ところがこれ自体が次の痛みを生む。



⦿ 悪循環（痛い → 固める → また痛い）が、腰痛を長引かせる正体のひとつ。

# 痛み × 恐怖がループする



恐怖で動きを止めるほど、痛みは取れにくくなる。  
“怖がらせない”ことが、それだけで治療になる。



## 「画像」と「痛み」は一致しない



ヘルニア・椎間板の変形・狭窄があっても、痛みのない人は大勢いる。

逆に、画像がキレイでも激痛のことも。＝ 痛み ≠ 構造の異常。



**NG** 「骨が変形してるから一生痛い」と患者に思い込ませること。恐怖を植えつけ、痛みを固定してしまう。

# だから、つらい腰痛にはこう向き合う



## ① 安心で恐怖を断つ

「動いて大丈夫」を伝える



## ② 動きを取り戻す

痛くない範囲で動かし、  
固まり・過敏化を緩める。



## ③ 過敏化を鎮める

リラックス・睡眠・呼吸で  
痛みの“音量”を下げる。

CHAPTER 03

## 第3章

# ぎっくり腰の メカニズム

あの瞬間、腰で何が起きているのか。発症から回復までを分解する。



# ぎっくり腰 = 急性腰痛。何が起きた？

「魔女の一撃」とも呼ばれる急性の腰痛。多くは中腰・ひねり・不意の動作がきっかけ。実は“疲労の蓄積”が下地にある。



# 犯人になりうる組織はいくつもある



椎間関節

捻挫・はさみ込み



筋・筋膜

微小な損傷・過収縮



椎間板

急な負荷・圧



仙腸関節

ねじれ・負担

実際には原因をひとつに特定できない“非特異的腰痛”が多数。だからこそメカニズムの理解で対応する。

# なぜ、あんなに動けなくなるのか



## 急激な防御収縮

腰を守ろうと筋が一気に固まり、動きをロックする。これは体の防衛反応。



## 炎症期（数日）

発痛物質が出て、組織が敏感に。動かすと激痛が走る“動くなアラーム”。



**ポイント** 激痛＝大ケガ ではない。多くは“動くな”という体の強い警報で、組織のダメージはそこまで大きくないことも多い。

# 多くは自然に回復していく

発症～3日

## 急性期

炎症で最も痛い。  
楽な姿勢で過ごす。



数日～1週

## 回復期

痛みが和らぐ。  
痛くない範囲で動き始める。



～2週間

## 軽快

多くはこの頃までに大幅に改善する。



### 注意

「とにかく安静で寝込む」はむしろ回復を遅らせる。痛くない範囲で動くのが今の常識。  
繰り返し起こりやすい症状なので、数ヶ月安静と適度な運動推奨

# 急性期にやること・避けること



## やること

- 楽な姿勢を見つけて休む
- 痛くない範囲で少しずつ動く
- 必要に応じ冷却/温め
- 安心できる説明をする



## 避けること

- 長期間ずっと寝込む
- 強い揉み返しを狙う
- 「骨がヤバい」と脅す
- 無理にボキボキ動かす



**これは医療へ：** 下肢のしびれ/麻痺の進行・排尿排便の異常・発熱・安静でも増す激痛・強い外傷後



SYNTHESIS

## 3つに共通する“分解の答え”

痛みは 「体」 × 「脳」 の合作



体の側

筋緊張・血流低下・炎症・防御収縮といった、実際に起きている現象。



脳の側

感作・注意・恐怖・ストレスが、その感覚を増幅したり長引かせる。

# 患者への“なぜ”説明トーク例

## 肩こり

「筋肉の血流が落ちて、脳が“張ってる”と感じている状態です。ほぐして血を巡らせ、脳の警戒も解いていきましょう」

## つらい腰痛

「痛みのセンサーが過敏になっているだけで、腰が壊れたわけではないですよ。少しずつ動かして慣らしていきましょう」

## ぎっくり腰

「今は体が“守れ”と固めている時期です。多くは数日で楽になります。動ける範囲で動かしていきましょう」

# メカニズムを施術に落とし込む



## 局所

筋をゆるめ血流を改善する



## 全身（自律神経）

呼吸・リラックスで過緊張を  
解く



## 認知（安心）

なぜ痛むかを説明し恐怖を断  
つ



## 動き

怖がらず動かし機能を取り戻  
す

「揉んで終わり」から、4つの面を組み合わせる施術へ。

# 捨てたい3つの誤解



## 誤解 1

### 揉めば治る

局所をほぐすだけでは、  
脳の感作や恐怖ループは解けない。



## 誤解 2

### 痛い＝壊れてる

痛みの強さは損傷の量と一致し  
ない。脅すと逆効果になる。



## 誤解 3

### とにかく安静

動かなすぎは回復を遅らせる。  
痛くない範囲で動くのが基本。

## ACTION

# 明日からやる3ステップ

1



“なぜ”を一言で言えるように

肩こり・腰痛・ぎっくり腰、それぞれの説明を自分の言葉で用意する。

2



怖がらせない前提に立つ

「痛み≠損傷」を踏まえ、脅さず安心を渡す声かけをする。

3



局所＋自律神経＋安心で組む

揉むだけで終わらせず、3つの面を毎回の施術に入れる。

## SUMMARY

# 今日の要点



痛みは脳が出す最終アウトプット。強さ＝損傷の量ではない。



肩こりの“こり感”は、筋・血流の問題と脳の増幅の合作。



つらい腰痛は、感作・防御スパズム・恐怖ループで増幅される。



ぎっくり腰の激痛は“動くな”の警報。多くは自然に軽快する。

## CONCLUSION

# “なぜ痛むか”を 語れる整体師に。

症状を分解する＝痛みのメカニズムを分解して、患者に言葉で返すこと。

それだけで、施術は「ほぐし」から「納得して通える体験」に変わる。

